

アレルギー疾患（喘息以外） 食物アレルギー・アトピー性皮膚炎



小児科 谷田寿志

本日の流れ



- 講義（20分）
 - アクティブラーニングのポイント
 - アトピー性皮膚炎
 - 食物アレルギー



- アクティブラーニング
 - グループワーク（30分）
 - 発表（40分）

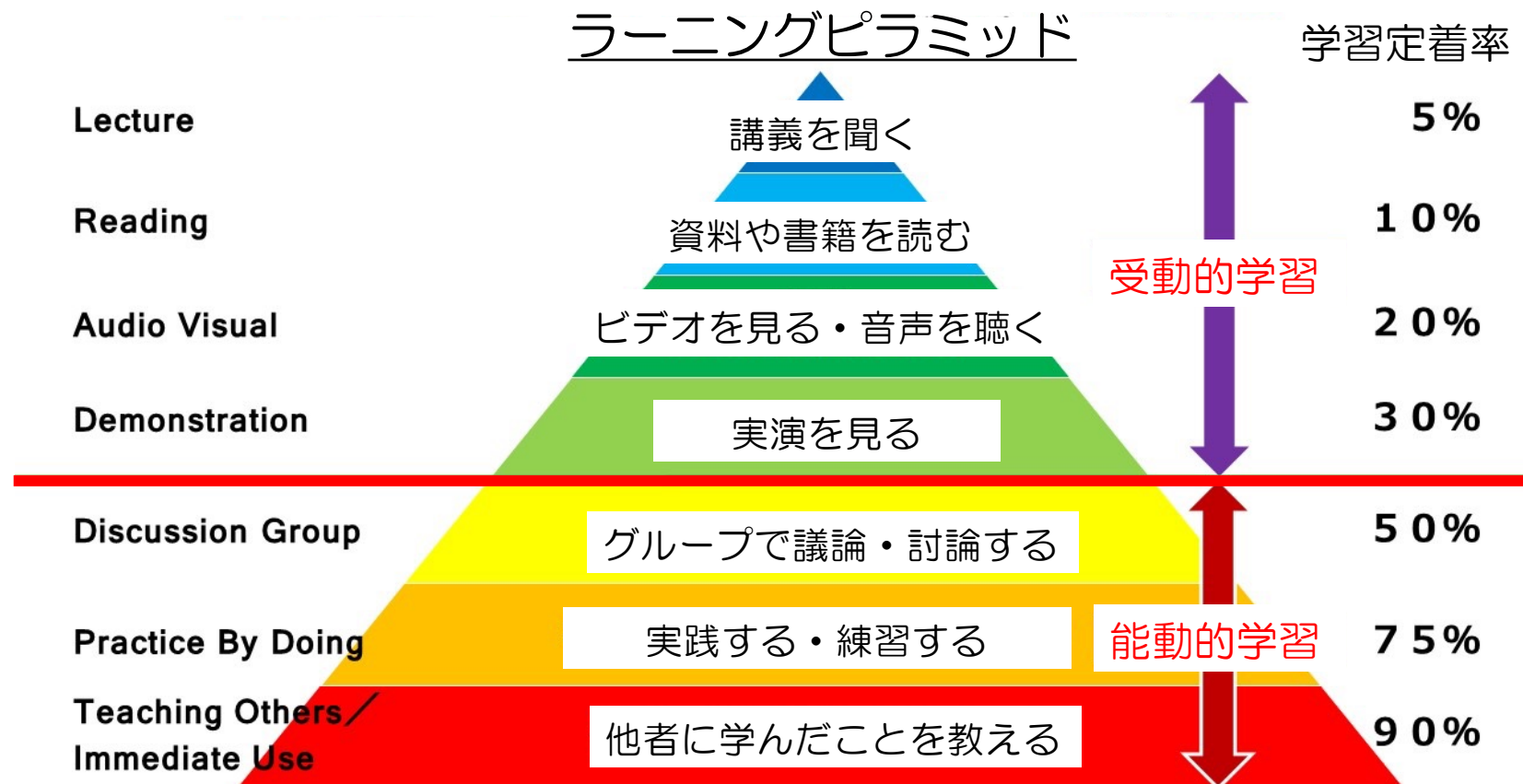


グループワークを通じて能動的に学び、
発表を通じてアウトプットする。



アクティブラーニングのポイント

～「議論・実践・教える」ことが定着率を上げる～



アトピー性皮膚炎：定義・診断基準

定義

- アトピー性皮膚炎は、増悪と軽快を繰り返す、掻痒のある湿疹を主病変とする疾患であり、患者の多くはアトピー素因を持つ。
- アトピー素因：①家族歴・既往歴(気管支喘息、アレルギー性鼻炎・結膜炎、アトピー性皮膚炎のうちいずれか、あるいは複数の疾患)、または②IgE 抗体を産生し易い素因。



アトピー性皮膚炎の診断基準

1. 掻痒

2. 特徴的皮疹と分布

①皮疹は湿疹病変

・急性病変：紅斑，湿潤性紅斑，丘疹，漿液性丘疹，鱗屑，痂皮

・慢性病変：浸潤性紅斑・苔癬化病変，痒疹，鱗屑，痂皮

②分布

・左右対側性

好発部位：前額，眼囲，口囲・口唇，耳介周囲，頸部，四肢関節部，体幹

・参考となる年齢による特徴

乳児期：頭，顔にはじまりしばしば体幹，四肢に下降。

幼小児期：頸部，四肢関節部の病変。

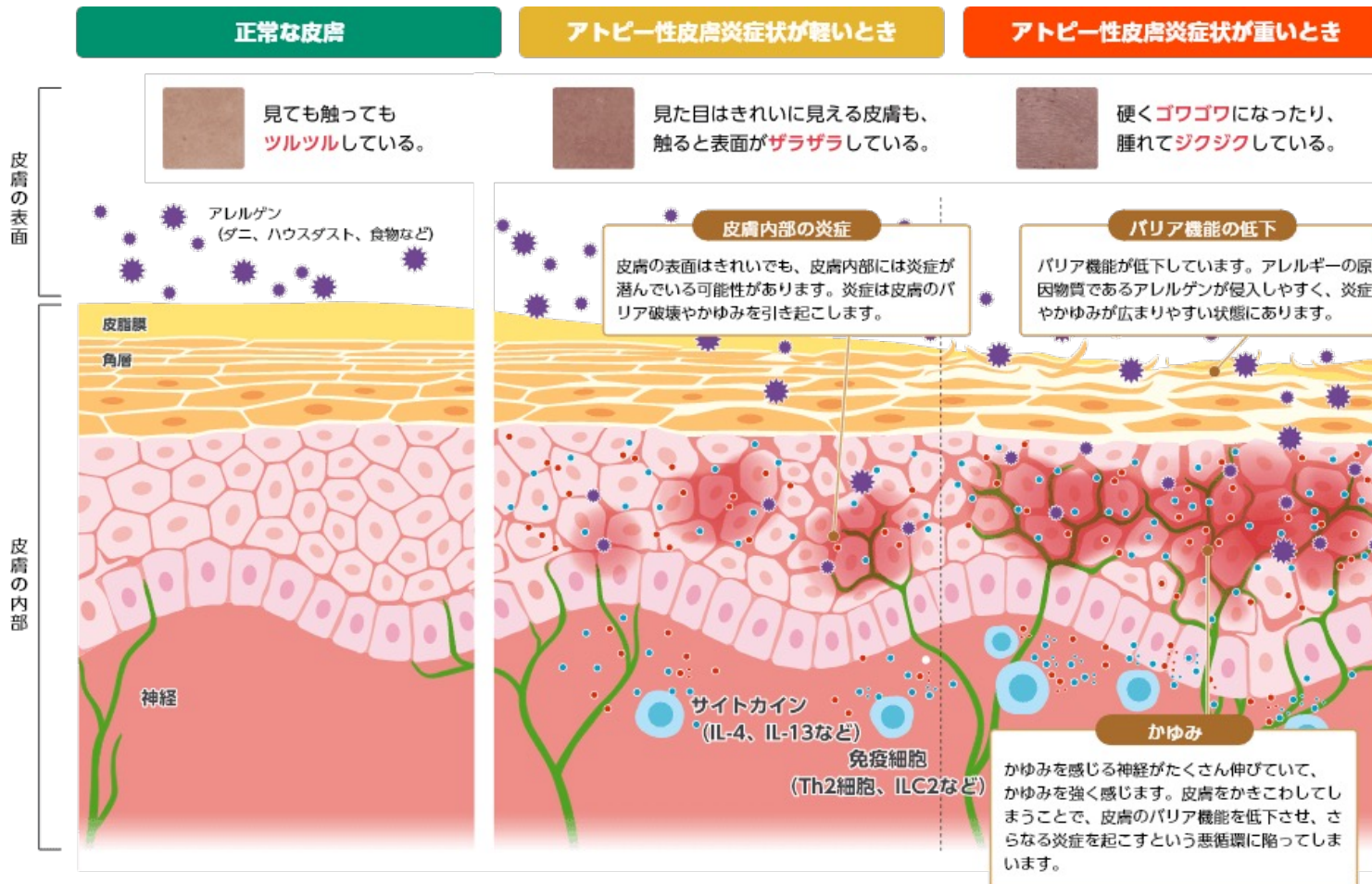
思春期・成人期：上半身（頭，頸，胸，背）に皮疹が強い傾向。

3. 慢性・反復性経過（しばしば新旧の皮疹が混在する）

：乳児では2カ月以上，その他では6カ月以上を慢性とする。

上記1，2，および3の項目を満たすものを，症状の軽重を問わずアトピー性皮膚炎と診断する。そのほかは急性あるいは慢性の湿疹とし，年齢や経過を参考にして診断する。

アトピー性皮膚炎：病態



炎症の悪循環

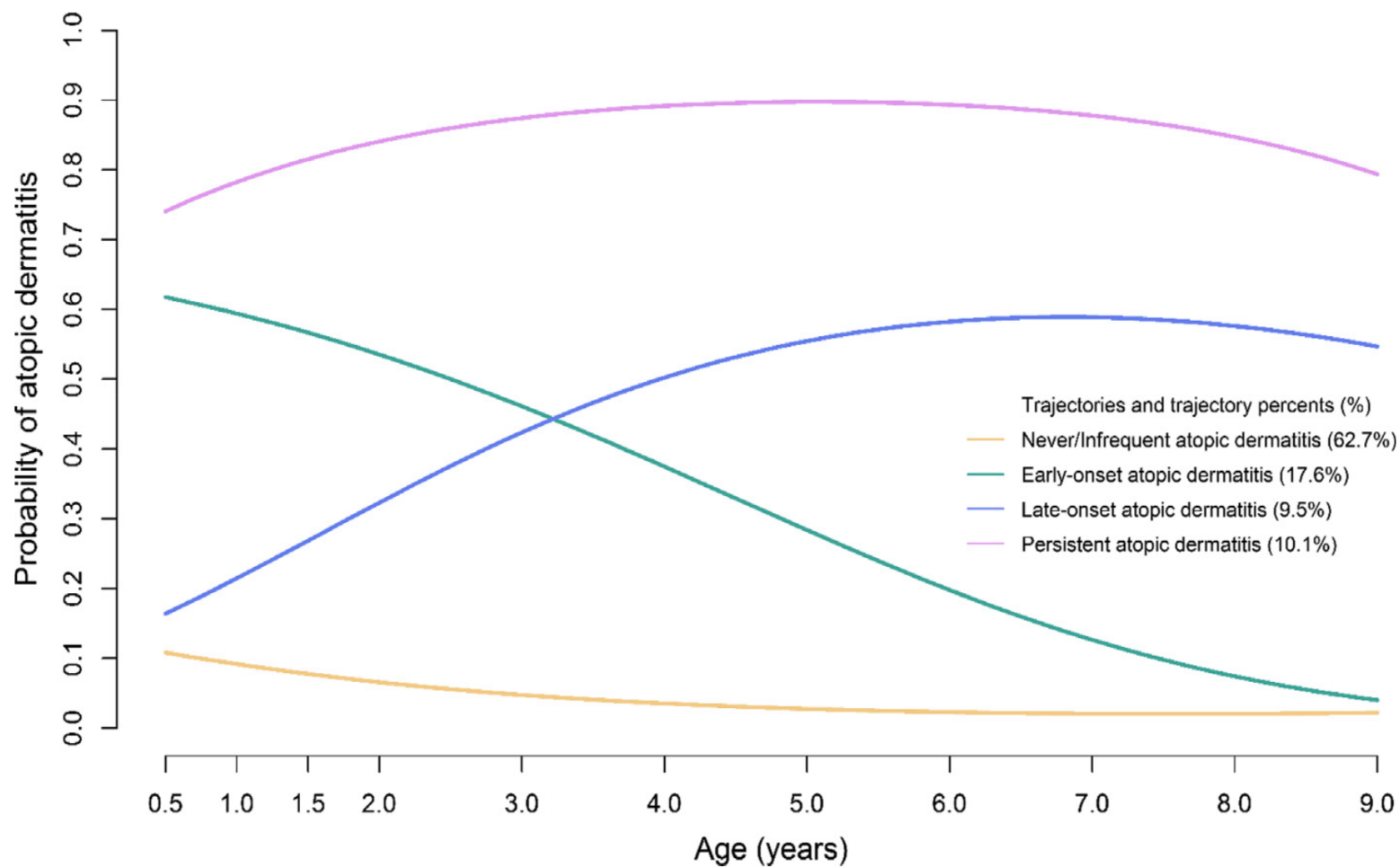
- 上皮バリア機能障害
- 炎症細胞浸潤
- 炎症性サイトカイン
- 知覚神経伸長
- 掻爬、湿潤・浮腫

見た目

- 紅斑
- 湿潤、浮腫
- 掻爬痕
- 苔癬化

アレルギー情報サイト：アレルギー i

アトピー性皮膚炎：疫学



- ① 乳児期から継続
- ② 幼児期から継続
- ③ 乳幼児期のみ
- ④ 時々症状を認める

アトピー性皮膚炎：スキンケア・外用薬塗布指導

入浴・洗淨

- 熱いお湯はかゆみを誘発することがある。
- タオルなどで擦らず、泡を利用し、手で洗う。
- しっかりと洗い流す。
- 長湯はかゆみを誘発することがある。



保湿剤塗布

- ワセリン
 - 油で乾燥ガード
- ヘパリン類似物質外用薬
 - 保湿因子で水分保持
- 入浴後に全身塗布。
- 1日2-3回塗布。



ステロイド外用薬塗布

- 小児ではⅣ群、Ⅲ群を使用することが多い。
- 湿疹周辺も含めて、FTUを意識して1日2回塗布。



動画解説：体の洗いか方・保湿剤の塗り方

<https://www.maruho.co.jp/araikata/index.html>

ステロイド外用薬ランク・プロアクティブ療法

ステロイド外用薬（抗炎症剤・免疫抑制剤）

ストロングスト（Ⅰ群）

- 0.05% クロベタゾールプロピオン酸エステル（デルモベート®）
- 0.05% ジフロラゾン酢酸エステル（ダイアコート®）

ベリーストロング（Ⅱ群）

- 0.1% モメタゾンフランカルボン酸エステル（フルメタ®）
- 0.05% ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル（アンテベート®）
- 0.05% フルオシノニド（トプシム®）
- 0.064% ベタメタゾンジプロピオン酸エステル（リンデロン DP®）
- 0.05% ジフルプレドナート（マイザー®）
- 0.1% アムシノニド（ビスダーム®）
- 0.1% ジフルコルトロン吉草酸エステル（テクスメテン®, ネリゾナ®）
- 0.1% 酪酸プロピオン酸ヒドロコルチゾン（パNDER®）

ストロング（Ⅲ群）

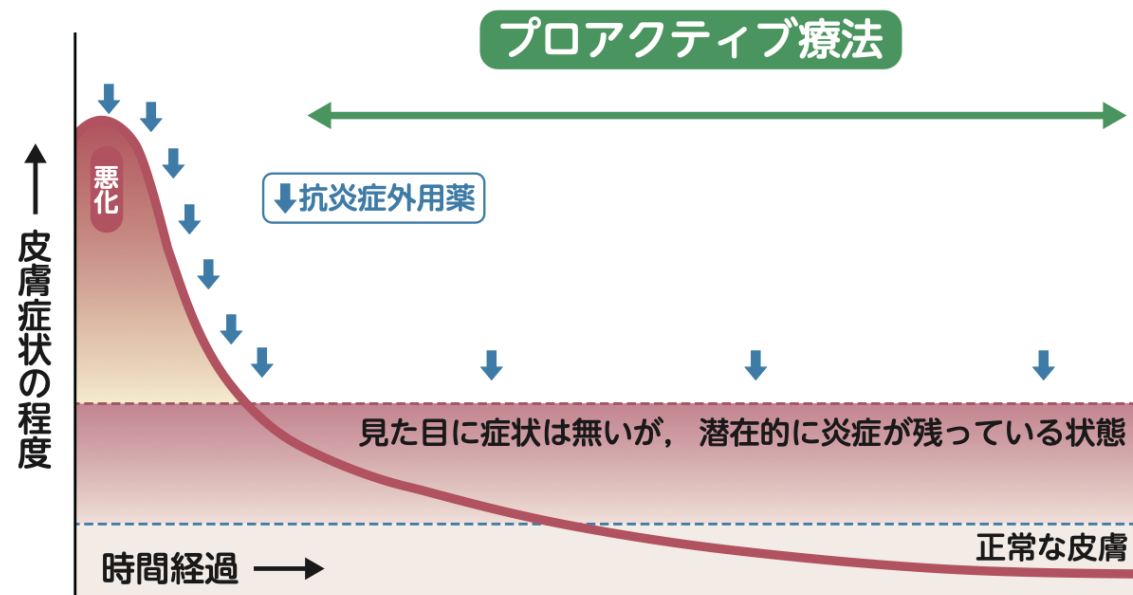
- 0.3% デプロドンプロピオン酸エステル（エクラー®）
- 0.1% デキサメタゾンプロピオン酸エステル（メサデルム®）
- 0.12% デキサメタゾン吉草酸エステル（ポアラ®, ザルックス®）
- 0.12% ベタメタゾン吉草酸エステル（ベトネベート®, リンデロン V®）
- 0.025% フルオシノロンアセトニド（フルコート®）

ミディアム（Ⅳ群）

- 0.3% プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル（リドメックス®）
- 0.1% トリアムシノロンアセトニド（レダコート®）
- 0.1% アルクロメタゾンプロピオン酸エステル（アルメタ®）
- 0.05% クロベタゾン酪酸エステル（キンダベート®）
- 0.1% ヒドロコルチゾン酪酸エステル（ロコイド®）
- 0.1% デキサメタゾン（グリメサゾン®, オイラゾン®）

ウィーク（Ⅴ群）

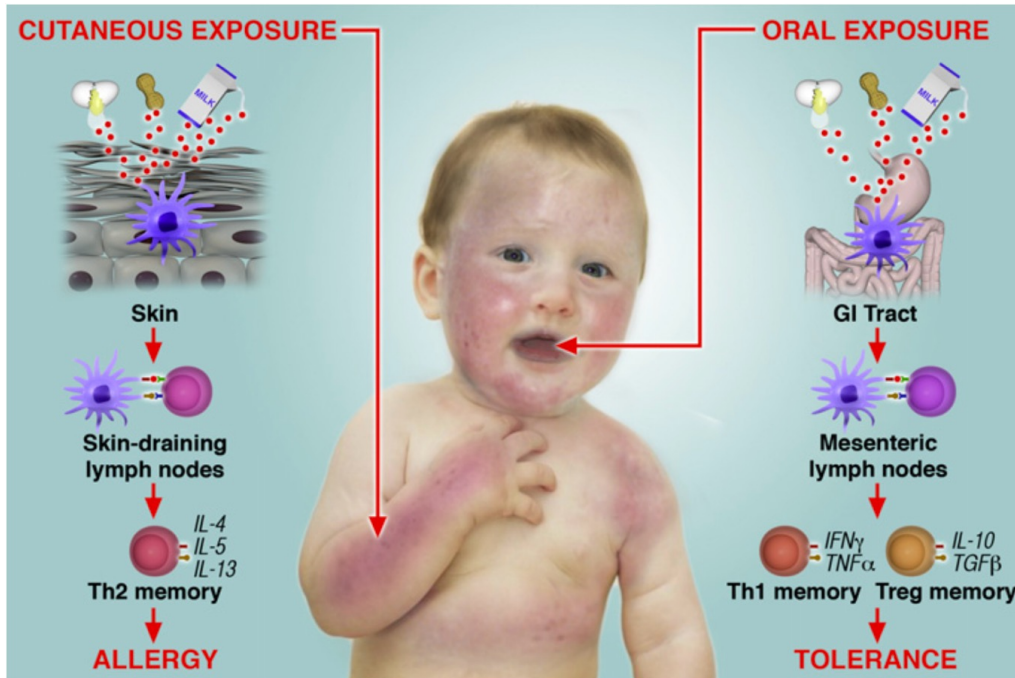
- 0.5% プレドニゾン（プレドニゾン®）



- 急性期
 - 1日2回塗布
- 維持期
 - 炎症を再燃させてない回数を塗布
 - 例：2日に1回

アトピー性皮膚炎と食物アレルギー

2008年：二重抗原暴露仮説



Lack, *J Allergy Clin Immunol*. 2008 121 :1331-6.

経皮感作

- 皮膚が赤く荒れている状態(湿疹)が食物アレルギーの原因の1つになっている。

※アトピー性皮膚炎がない食物アレルギー児もたくさんいます。

経口免疫寛容

- 食物を食べることが食物アレルギーの予防や早期の緩和につながっている。

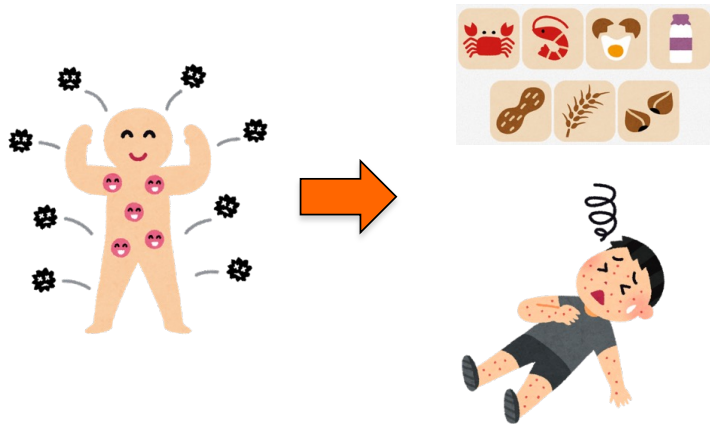
卵・乳・小麦アレルギーの基本診療

- ステロイド軟膏で湿疹をなくす。
- 摂取可能な量を食べる（未摂取・摂取済に関わらず）。

食物アレルギーとは

- 細菌やウイルスなどの外敵から体を守るべき働き（免疫）が過剰に働くことで本来無害である食物に対して反応するようになり、体にとって不都合な症状が誘発されること。

小児食物アレルギーQ&A（日本医事新報社）



不都合な症状が起こる場所

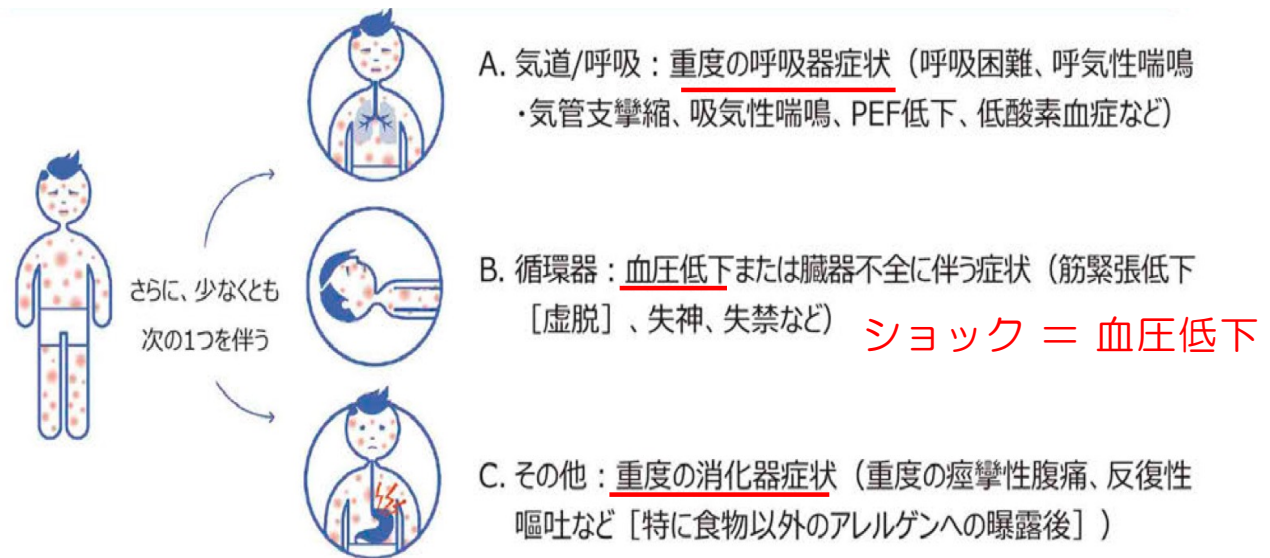
皮膚・呼吸・循環(心臓 血管)・消化器

アナフィラキシーの診断基準：①皮膚症状あり

※②皮膚症状なしの診断基準もあります

1. 皮膚、粘膜、またはその両方の症状（全身性の蕁麻疹、痒痒または紅潮、口唇・舌・口蓋垂の腫脹など）が急速に（数分～数時間で）発症した場合。

赤くて痒くて、腫れる



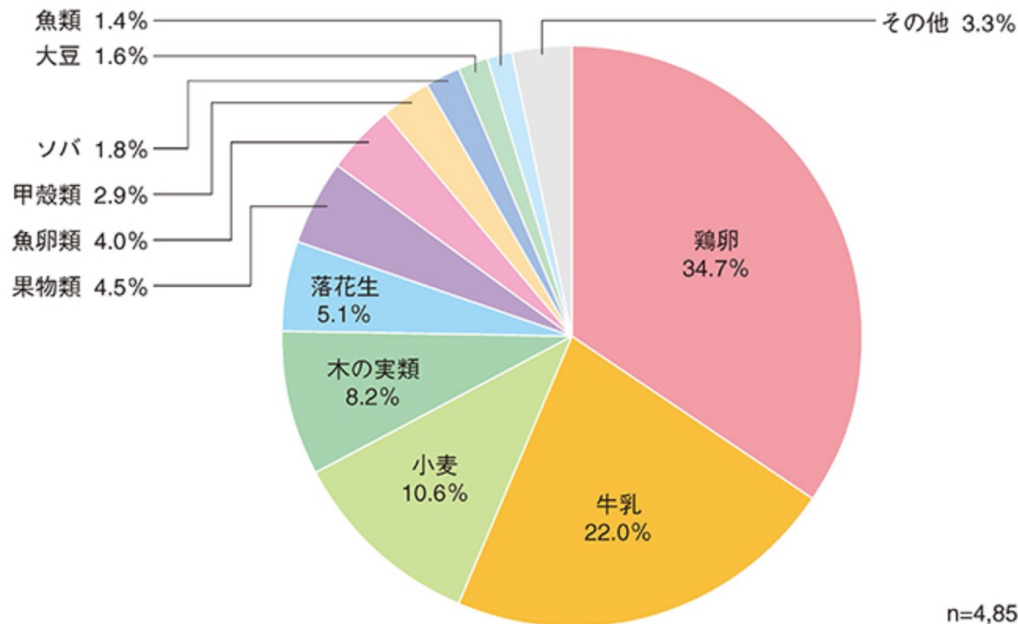
典型的皮膚症状 =

アレルゲン不明でもアレルギーの可能性が高い

アナフィラキシーガイドライン2022

食物アレルギー：疫学

原因食物



新規発症原因食物

	0歳 (1,356)	1、2歳 (676)	3~6歳 (369)	7~17歳 (246)	≥18歳 (117)
1	鶏卵 55.6%	鶏卵 34.5%	木の実類 32.5%	果物類 21.5%	甲殻類 17.1%
2	牛乳 27.3%	魚卵類 14.5%	魚卵類 14.9%	甲殻類 15.9%	小麦 16.2%
3	小麦 12.2%	木の実類 13.8%	落花生 12.7%	木の実類 14.6%	魚類 14.5%
4		牛乳 8.7%	果物類 9.8%	小麦 8.9%	果物類 12.8%
5		果物類 6.7%	鶏卵 6.0%	鶏卵 5.3%	大豆 9.4%

落花生：土の中でできる
木の実類：木に成る

3大アレルゲン

- ・ 鶏卵、牛乳、小麦

意外に少ない

- ・ 落花生、甲殻類、ソバ

※便宜上：ナッツ類 = 木の実類 + 落花生
と、この講義ではさせていただきます。

ナッツ類アレルギーの増加とアナフィラキシーショック

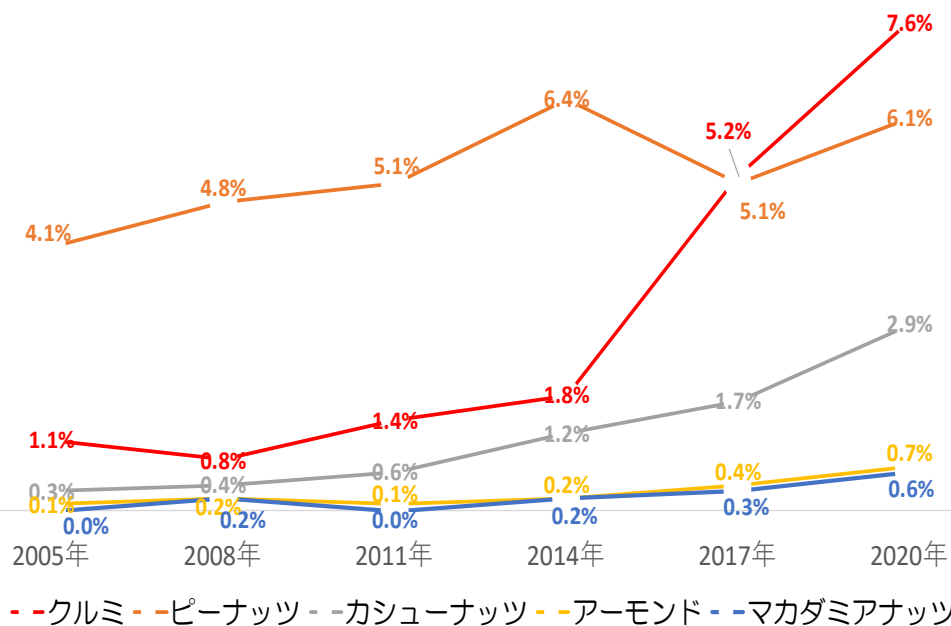
増加：クルミ(ペカン)・カシュー(ピスタチオ)

- 健康志向による消費者ニーズの増加
- 輸入量の増加

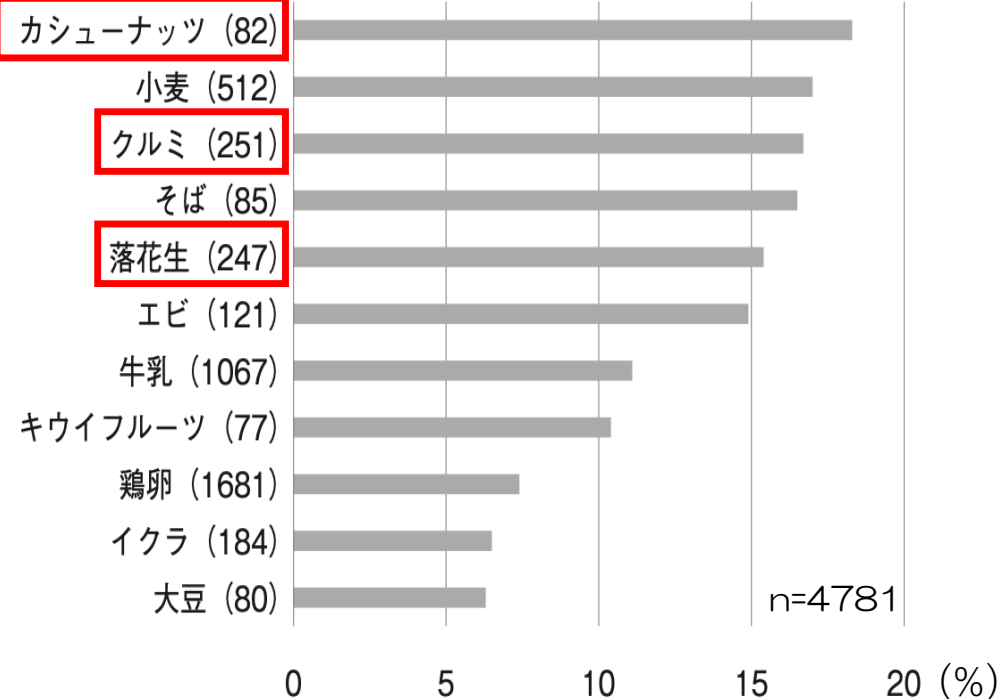
原因食物別
アナフィラキシーショック発症率

- ナッツ類アレルギーはアナフィラキシーショック率が高い

食物アレルギーに占める各ナッツアレルギーの推移



消費者庁調査研究事業報告書 2021年度



消費者庁全国モニタリング調査結果報告2017年

アドレナリン自己注射薬：エピペン®

- 効能
 - 心拍数増加
 - 血圧上昇（末梢血管収縮）
 - 気管支拡張（気管平滑筋弛緩）
- 効果
 - 血中濃度：筋注後約10分で最高。約40分程度で半減。
 - 効果が切れると症状が再燃する。
- ポイント
 - 即効性に優れているが、症状が強く持続するときは複数回の投与が必要。
 - 一時しのぎであるため、患者指導の際は、救急要請など医療機関受診が必須。
- 2008年
教職員などが実施することは、医師法違反にならないと文部科学省が示した。
- 2009年
救急救命士による投与解禁が厚生労働省より示された。



▲ 製品(エピペン® 注射液)0.15mg

約15-30kg児用



▲ 製品(エピペン® 注射液)0.3mg

約30kg以上児用